Popayán, Cauca, Colombia, 04 de abril de 2025

Señores:

Fundación Universitaria de Popayán
Área de Registro y Control Académico
Programa de Piscología

Referencia: Derecho de Petición - Solicitud de modificación de requisitos de grado por razones humanitarias.

Respetados Señores,

Yo, Michel Valentina Velez Rosero, identificada con cédula de ciudadanía No. 1094945031 de Armenia, Quindío, actuando en nombre de mi hermana Karol Gabriela Velez Rosero, identificada con cédula de ciudadanía No.1193103725 de Orito Putumayo, estudiante del programa de Psicología de su prestigiosa institución, **me permito presentar el presente Derecho de Petición**, de conformidad con lo establecido en los artículos 23 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 1755 de 2015, y demás normas concordantes que regulan el derecho fundamental de petición.

ANTECEDENTES:

1. Mi hermana, Karol Gabriela Velez Rosero, ha sido estudiante ejemplar del programa de Psicología de su institución, demostrando un rendimiento académico sobresaliente a lo largo de su carrera; rendimiento que fue recompensado por la institución permitiéndole ser monitora y obtener un descuento en su matrícula.

2. Desde el año 2023, ella enfrenta un cáncer agresivo que la ha obligado a interrumpir sus estudios en dos ocasiones (una de esas interrupciones la hizo el año en curso), impidiendo su graduación junto a sus compañeros iniciales quienes obtuvieron su título profesional este semestre 2025-I.

3. Durante su proceso médico, mi hermana ha tenido que someterse a múltiples cirugías, quimioterapias, radioterapias, radiocirugía y, lamentablemente, en el proceso de estos tratamientos ha perdido algunas de sus capacidades físicas, incluida su motricidad y habla, que con cada intervención debe recuperar a través de muchas sesiones de terapia. A pesar de estas adversidades, ha mantenido su voluntad y ánimo no solo por recuperar su salud sino por continuar sus estudios y alcanzar su título profesional, es una de sus motivaciones más grandes.

4. La Fundación Universitaria de Popayán ha demostrado en ocasiones anteriores su sensibilidad ante situaciones excepcionales, como cuando se otorgan títulos póstumos a estudiantes fallecidos, en reconocimiento a su esfuerzo y dedicación. Pero en el caso particular, también sabemos del apoyo que ha recibido mi hermana por parte del cuerpo docente y administrativo de esta alma máter.

5. Es importante señalar que la obtención de su título profesional representaría un factor de gran importancia para su bienestar emocional y psicológico, ya que le permitiría culminar un proceso que ha sido fundamental en su motivación para seguir luchando contra su enfermedad. Este proceso de graduación es esencial para su salud mental, pues la imposibilidad de graduarse junto a sus compañeros ha sido una experiencia emocionalmente difícil y desmotivadora.

PETICIÓN:

Solicito respetuosamente que, en consideración a las razones humanitarias expuestas y con fundamento en los principios de dignidad humana, igualdad y derecho a la educación consagrados en la Constitución Política de Colombia (Artículos 1, 13, 49 y 67), así como en la Ley Estatutaria 1755 de 2015 que reglamenta el Derecho de Petición, se otorgue a mi hermana Karol Gabriela Velez una alternativa excepcional para la culminación de su carrera profesional.

Específicamente, solicito que se le permita optar por un trabajo académico alternativo, como la realización de un material audiovisual (video, podcast, programa de radio,etc) o un ensayo-monografía de alta calidad relacionado con su formación en Psicología[1], en lugar de los requisitos estándar de práctica profesional y tesis, dada su condición médica actual.

FUNDAMENTOS LEGALES:

1. Constitución Política de Colombia:

Artículo 1: Principio de dignidad humana.
Artículo 13: Derecho a la igualdad, protección especial a personas en condición de vulnerabilidad.
Artículo 49: Derecho a la salud, incluyendo salud mental y bienestar emocional.
Artículo 67: Derecho fundamental a la educación.

2. Ley 1755 de 2015:
Regula el derecho fundamental de petición, otorgando a toda persona la facultad de presentar solicitudes respetuosas ante autoridades públicas o privadas que cumplen funciones públicas, y obtener una respuesta en términos razonables.

3. Ley 1616 de 2013 (Ley de Salud Mental):
Artículo 1: Reconoce la salud mental como un derecho fundamental y parte integral del bienestar general.

[1] Reglamento General de las Alternativas de Grado, Fundación Universitaria de Popayán, Pág. 7 de 17 https://fup.edu.co/wp-content/uploads/reglamento-alternativa-de-grado.pdf

Artículo 4: Establece el derecho a recibir atención integral en salud mental, respetando la dignidad humana y la inclusión social.

Artículo 5: Promueve estrategias que fortalezcan la calidad de vida y bienestar psicológico de las personas.

4. Principios de flexibilidad y equidad:
En consideración a la situación excepcional de mi hermana, se solicita que se aplique un criterio de flexibilidad y equidad para permitirle culminar sus estudios bajo un esquema ajustado a sus capacidades actuales.

ANEXOS:

Certificados o informes médicos que respaldan la situación de salud de mi hermana, Karol Gabriela Velez Rosero (Historia clínica extendida)

PLAZO DE RESPUESTA:

Solicito respetuosamente que se dé respuesta a la presente petición en un término **no mayor** a quince (15) días hábiles, de conformidad con lo estipulado en la Ley 1755 de 2015 y que dicha respuesta sea clara y concreta frente a las opciones que puede o no la universidad ofrecernos y enviada al correo electrónico valentinavelezcsp@gmail.com

Finalmente, hago un llamado a la empatía y al compromiso de la institución con la inclusión, la equidad y la responsabilidad social, permitiendo que mi hermana, quien ha demostrado su excelencia académica y resiliencia personal, tenga la oportunidad de recibir su título profesional de manera justa y acorde a sus condiciones actuales.

Quedo atenta a su pronta y positiva respuesta.

Atentamente,

Michel Valentina Velez Rosero
1094945031 de Armenia Quindío
3125563969
valentinavelezcsp@gmail.com

FUNDACIÓN VALLE DEL LILI
Excelencia en Salud al servicio de la comunidad

HISTORIA CLÍNICA GENERAL

Avenida Simón Bolivar
Carrera 98 No. 18 - 49
Conmutador 602 3319090
Fax 602 3316728
Nit. 8903241775
www.valledellili.org
CALI - COLOMBIA

DATOS GENERALES

Paciente:	**KAROL GABRIELA VELEZ ROSERO**			Doc.Identificación:	**CC 1193103725**
Fecha Nacimiento:	**26.12.2001**	Edad:	**23 Años 01 Meses 11 días**	Sexo Biológico: **F**	Nº. Episodio: **0012920172**
Aseguradora:	**NUEVA EPS S.A. RS**			Nº. Historia Clínica:	**0001677605**
Servicio de ingreso	**EURGEXP4 REPS 760010287001**			Fecha ingreso	**30.01.2025 18:54:42**
Servicio de egreso				Fecha egreso	
Médico Tratante:	**VALENTINA ACOSTA ZAPPARRATA**	**FISIOTERAPIA**			

ATENCIÓN CLÍNICA

Estado de ingreso:	Vivo	Voluntad Anticipada:	No
Finalidad de la consulta:	TRATAMIENTO	Causa Externa:	ENFERMEDAD GENERAL

Motivo de consulta, enfermedad actual, revisión de síntomas por sistemas, examen físico, análisis y conducta

Fecha:	30-ene-25	Hora:	14:19:38

MOTIVO DE CONSULTA remitida de consulta externa

enfermedad actual: paciente con anteceden de *GLIOBLASTOMA MULTIFORME TALÁMICO IZQUIERDO *POP RESECCIÓN 12 DE MAYO DE 2023.
CULMINÓ RADIOTERAPIA EN CONCOMITANCIA CON TEMOZOLADMIDA EL 3/8/2023.
** TEMOZOLAMIDA POR 6 MESES MÁS TERMINÓ EN NOVIMEBRE 2024

valorada por neurocirugia quienen encuentra reporte de RESONANCIA CEREBRAL CONTRASTADA (25.01.2025) SE OBSERVA LESIÓN REALZANTE CON EL MEDIO DE CONTRASTE EN TÁLAMO IZQUIERDO. EN T2 SE VE RELATIVAMENTE BIEN DELIMITADO, EN LOS MAPAS DE PERFUSIÓN MUESTRA VASCULARIZACIÓN. ASOCIADO A UN EDEMA VASOGÉNICO FRONTO PARIETAL EXTENSO (LAS CARACTERÍSTICAS DE LA LESIÓNPREQUIRÚRGICA NO MOSTRABA EDEMA SIGNIFICATIVO).

antecednetes
*PATOLOGÍA:
Células tumorales positivas para GFAP, Olig2 y S100. P53 no sobre-expresado. Índice de proliferación medido
mediante KI67 es del 20-25%.
IDH: Células tumorales negativas para IDH (R132H).
TUMOR TALAMICO IZQUIERDO - RESECCIÓN.
- GLIOBLASTOMA DE TIPO IDH NATIVO (GRADO 4 DE LA OMS) P53 NO SOBRE EXPRESADO

ANTECEDENTES:
-PATOLÓGICOS: LESIÓN SUBEPENDIMARIA EN ASTA FRONTAL DEL VENTRÍCULO LATERAL IZQUIERDO, MIOMATOSIS UTERINA, OVARIOS POLIQUÍSTICOS.
-FARMACOLÓGICOS: ACETAMINOFÉN, NAPROXENO.
-ALERGIAS: NIEGA
-QUIRÚRGICOS: BIOPSIA ESTEREOTÁXICA EL 20.04.2023
-TÓXICOS: NIEGA
-FAMILIARES: NIEGA
-INMUNOLÓGICOS: 1 DOSIS PARA SARS-COV 2

AL EXAMEN FISICO,
ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES
ALERTA, ORIENTADA
LENGUAJE FLUIDO, SIN PARAFASIAS, COMPRENDE BIEN
MOVIMIENTOS EXTRAOCULARES CONSERVADOS
HEMIPARESIA DENSA BRAQUICRURAL DERECHA 4/5
BABYNSKI DERECHO.
SENSITIVO NORMAL, COORDINACION NORMAL.
ARREFLEXIA GENERALIZADA
DISMETRIA Y DISADIADOCOCINESIAS (-)

* RESONANCIA CEREBRAL CONTRASTADA (25.01.2025)
SE OBSERVA LESIÓN REALZANTE CON EL MEDIO DE CONTRASTE EN TÁLAMO IZQUIERDO. EN T2 SE VE RELATIVAMENTE BIEN DELIMITADO, EN LOS MAPAS DE PERFUSIÓN MUESTRA VASCULARIZACIÓN. ASOCIADO A UN EDEMA VASOGÉNICO FRONTO PARIETAL EXTENSO (LAS CARACTERÍSTICAS D ELA LESIÓNPREQUIRÚRGICA NO MOSTRABA EDEMA SIGNIFICATIVO).

IMPRESIÓN:
SE DEBE DESCARTAR RECIDIVA TUMORAL VS CAMBIOS POR RADIACIÓN DE MANERA URGENTE. SE INGRESA A URGENICAS PARA HOSPITALIZACIÓN, REALIZACIÓN DE ESPECTROSCOPIA, INICIO DE ESTEROIDES Y EVALUACIÓN POR ONCOLOGÍA PARA CONSIDERAR NUEVAS ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS EN CASO DE RECIDIVA TUMORAL.

SE EXPLICA A LA PACIENTE QUE REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR

Responsable:	ESTRADA MESA, MARIA MANUELA	MEDICINA GENERAL	N. Identificación:	1144146023
RM:	7662232014	Válido Como Firma Electrónica		

Signos Vitales

Tensión arterial:	128 / 077	Tension arterial media:	94.00	Frecuencia cardiaca:	085	Frecuencia respiratoria:	018	Temperatura(°C):	36.00
Dolor(0/10):	2	Saturación sin 02:	100	Saturación con 02:		Perímetro abdominal:	0.00	Peso(kg):	0.00
Talla(CM):	0.00	Indice masa corporal:	0.00	Superficie corporal:	0.00				

Conciliación de Medicamentos

Paciente viene recibiendo medicamentos antes del ingreso? No

Diagnósticos

Fecha: 30-ene-25 C719 TUMOR MALIGNO DEL ENCEFALO, PARTE NO ESP

Órdenes Clínicas

Fecha	Código	Nombre	U. Organizativa	Responsable
30-ene-25	890402-72	INTERCONSULTA DE URGENCIAS	UE Urgencias adulto	ESTRADA MESA, MARIA MANUELA
30-ene-25	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS IN	UE Urgencias adulto	ESTRADA MESA, MARIA MANUELA
30-ene-25	903856	NITROGENO UREICO	UE Urgencias adulto	ESTRADA MESA, MARIA MANUELA
30-ene-25	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS	UE Urgencias adulto	ESTRADA MESA, MARIA MANUELA
30-ene-25	903864	SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS	UE Urgencias adulto	ESTRADA MESA, MARIA MANUELA
30-ene-25	903859	POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS	UE Urgencias adulto	ESTRADA MESA, MARIA MANUELA
30-ene-25	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL	UE Urgencias adulto	DIAZ GUTIERREZ, ERIKA LORENA
31-ene-25	883905	ESPECTROSCOPIA	UE Urgencias adulto	ESTRADA MESA, MARIA MANUELA
31-ene-25	MEDIOCONTR	MEDIO DE CONTRASTE	UE Urgencias adulto	ESTRADA MESA, MARIA MANUELA
01-feb-25	890409-009	TAMIZAJE PSICOSOCIAL	UE Urgencias adulto	ORTIZ NIÑO, LUZ MARINA
02-feb-25	903883-001	GLUCOSA SEMIAUTOMATIZADA [GLUCOMETRIA] CU	UE Urgencias adulto	RIVERA LONDOÑO, JHON ROBERT
02-feb-25	903883-001	GLUCOSA SEMIAUTOMATIZADA [GLUCOMETRIA] CU	UE Urgencias adulto	RIVERA LONDOÑO, JHON ROBERT
03-feb-25	883106	RESONANCIA MAGNETICA DE CEREBRO CON TRACTOGRAFIA	UE Urgencias adulto	LOBATO POLO, JAVIER MAURICIO
03-feb-25	930102	PRUEBA COGNITIVA (CADA UNA)	UE Urgencias adulto	ULLOA ZULUAGA, ANA MARIA
03-feb-25	903883-001	GLUCOSA SEMIAUTOMATIZADA [GLUCOMETRIA] CU	UE Urgencias adulto	RIVERA LONDOÑO, JHON ROBERT
04-feb-25	990204-51	INFORMACION AL CUIDADOR Y PACIENTE POR ENFERMERIA EN EL PROGRAMA DE ACCESOS VASCULARES	UE Urgencias adulto	CASTRILLON MURILLO, SANDRA MILENA
04-feb-25	389103-006	SEGUIMIENTO CATETER VENOSO PERIFERICO	UE Urgencias adulto	CASTRILLON MURILLO, SANDRA MILENA
04-feb-25	902049	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP]	UE Urgencias adulto	ULLOA ZULUAGA, ANA MARIA
04-feb-25	911019	HEMOCLASIFICACION SISTEMA ABO INVERSA [HEMOCLASIFICACION SERICA] POR MICROTECNICA	UE Urgencias adulto	ULLOA ZULUAGA, ANA MARIA
04-feb-25	911017	HEMOCLASIFICACION SISTEMA ABO DIRECTA [HEMOCLASIFICACION GLOBULAR] POR MICROTECNICA	UE Urgencias adulto	ULLOA ZULUAGA, ANA MARIA
04-feb-25	902045	TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]	UE Urgencias adulto	ULLOA ZULUAGA, ANA MARIA
04-feb-25	911015	HEMOCLASIFICACION SISTEMA Rh [ANTIGENO Rh D] POR MICROTECNICA	UE Urgencias adulto	ULLOA ZULUAGA, ANA MARIA
04-feb-25	911003	ANTICUERPOS IRREGULARES DETECCION (COOMBS INDIRECTO RASTREO ANTICUERPOS IRREGULARES PRUEBA DE ANTIGLOBULINA INDIRECTA ES	UE Urgencias adulto	ULLOA ZULUAGA, ANA MARIA
04-feb-25	911021	PRUEBA CRUZADA MAYOR ERITROCITARIA POR MICROTECNICA	UE Urgencias adulto	ULLOA ZULUAGA, ANA MARIA
04-feb-25	911021	PRUEBA CRUZADA MAYOR ERITROCITARIA POR MICROTECNICA	UE Urgencias adulto	ULLOA ZULUAGA, ANA MARIA
05-feb-25	903111	ACIDO LACTICO [L-LACTATO] AUTOMATIZADO	UE Urgencias adulto	MORALES LOPEZ, AURA MARCELA
05-feb-25	903813	CLORO	UE Urgencias adulto	MORALES LOPEZ, AURA MARCELA
05-feb-25	903839	GASES ARTERIALES (EN REPOSO O EN EJERCICIO)	UE Urgencias adulto	MORALES LOPEZ, AURA MARCELA
05-feb-25	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS IN	UE Urgencias adulto	MORALES LOPEZ, AURA MARCELA
05-feb-25	903864	SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS	UE Urgencias adulto	MORALES LOPEZ, AURA MARCELA
05-feb-25	903859	POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS	UE Urgencias adulto	MORALES LOPEZ, AURA MARCELA
05-feb-25	901217-31	CULTIVO RASTREO EN HISOPADO RECTAL	UE Urgencias adulto	MORALES LOPEZ, AURA MARCELA
05-feb-25	887101	NAVEGACION ELECTROMAGNETICA COMO GUIA DEPROCEDIMIENTOS	UE Urgencias adulto	LOBATO POLO, JAVIER MAURICIO

05-feb-25	17401	RESECCION DE LESION O TUMOR DE LINEA MEDIA SUPRATENTORIAL POR CRANEOTOMIA	UE Urgencias adulto	LOBATO POLO, JAVIER MAURICIO
05-feb-25	908420-186	ESTUDIOS MOLECULARES DE GENES ESPECIFICOS ESTUDIO DE METILACION PARA EL GEN MGMT	UE Urgencias adulto	LOBATO POLO, JAVIER MAURICIO
05-feb-25	903883-001	GLUCOSA SEMIAUTOMATIZADA [GLUCOMETRIA] CU	UE Urgencias adulto	GOMEZ CORDOBA, MARIA JOSE
05-feb-25	903883-001	GLUCOSA SEMIAUTOMATIZADA [GLUCOMETRIA] CU	UE Urgencias adulto	CEPEDA LOPEZ, AURA MILENA
05-feb-25	890409-009	TAMIZAJE PSICOSOCIAL	UE Urgencias adulto	TROCHEZ DELGADO, JHON JAIRO
05-feb-25	890613	ASISTENCIA INTRAHOSPITALARIA POR TERAPIA OCUPACIONAL	UE Urgencias adulto	CATACOLI SAMAYOA, JOSE GERMAN
05-feb-25	890613	ASISTENCIA INTRAHOSPITALARIA POR TERAPIA OCUPACIONAL	UE Urgencias adulto	CATACOLI SAMAYOA, JOSE GERMAN
05-feb-25	890613	ASISTENCIA INTRAHOSPITALARIA POR TERAPIA OCUPACIONAL	UE Urgencias adulto	CATACOLI SAMAYOA, JOSE GERMAN
05-feb-25	903883-001	GLUCOSA SEMIAUTOMATIZADA [GLUCOMETRIA] CU	UE Urgencias adulto	CEPEDA LOPEZ, AURA MILENA
05-feb-25	890402	INTERCONSULTA POR OTRAS ESPECIALIDADES MEDICAS	UE Urgencias adulto	ULLOA ZULUAGA, ANA MARIA
05-feb-25	931001-03	TERAPIA FISICA INTEGRAL NEUROLOGICA HOSPITALARIA	UE Urgencias adulto	CATACOLI SAMAYOA, JOSE GERMAN
05-feb-25	890613	ASISTENCIA INTRAHOSPITALARIA POR TERAPIA OCUPACIONAL	UE Urgencias adulto	CATACOLI SAMAYOA, JOSE GERMAN
05-feb-25	931001-03	TERAPIA FISICA INTEGRAL NEUROLOGICA HOSPITALARIA	UE Urgencias adulto	CATACOLI SAMAYOA, JOSE GERMAN
05-feb-25	931001-03	TERAPIA FISICA INTEGRAL NEUROLOGICA HOSPITALARIA	UE Urgencias adulto	CATACOLI SAMAYOA, JOSE GERMAN
05-feb-25	931001-03	TERAPIA FISICA INTEGRAL NEUROLOGICA HOSPITALARIA	UE Urgencias adulto	CATACOLI SAMAYOA, JOSE GERMAN
05-feb-25	931001-03	TERAPIA FISICA INTEGRAL NEUROLOGICA HOSPITALARIA	UE Urgencias adulto	CATACOLI SAMAYOA, JOSE GERMAN
05-feb-25	931001-03	TERAPIA FISICA INTEGRAL NEUROLOGICA HOSPITALARIA	UE Urgencias adulto	CATACOLI SAMAYOA, JOSE GERMAN
05-feb-25	931001-03	TERAPIA FISICA INTEGRAL NEUROLOGICA HOSPITALARIA	UE Urgencias adulto	CATACOLI SAMAYOA, JOSE GERMAN
05-feb-25	931001-03	TERAPIA FISICA INTEGRAL NEUROLOGICA HOSPITALARIA	UE Urgencias adulto	CATACOLI SAMAYOA, JOSE GERMAN
05-feb-25	931001-03	TERAPIA FISICA INTEGRAL NEUROLOGICA HOSPITALARIA	UE Urgencias adulto	CATACOLI SAMAYOA, JOSE GERMAN
05-feb-25	890613	ASISTENCIA INTRAHOSPITALARIA POR TERAPIA OCUPACIONAL	UE Urgencias adulto	CATACOLI SAMAYOA, JOSE GERMAN
05-feb-25	890613	ASISTENCIA INTRAHOSPITALARIA POR TERAPIA OCUPACIONAL	UE Urgencias adulto	CATACOLI SAMAYOA, JOSE GERMAN
05-feb-25	890613	ASISTENCIA INTRAHOSPITALARIA POR TERAPIA OCUPACIONAL	UE Urgencias adulto	CATACOLI SAMAYOA, JOSE GERMAN
05-feb-25	890613	ASISTENCIA INTRAHOSPITALARIA POR TERAPIA OCUPACIONAL	UE Urgencias adulto	CATACOLI SAMAYOA, JOSE GERMAN
05-feb-25	890613	ASISTENCIA INTRAHOSPITALARIA POR TERAPIA OCUPACIONAL	UE Urgencias adulto	CATACOLI SAMAYOA, JOSE GERMAN
05-feb-25	890613	ASISTENCIA INTRAHOSPITALARIA POR TERAPIA OCUPACIONAL	UE Urgencias adulto	CATACOLI SAMAYOA, JOSE GERMAN
06-feb-25	903883-001	GLUCOSA SEMIAUTOMATIZADA [GLUCOMETRIA] CU	UE Urgencias adulto	GOMEZ CORDOBA, MARIA JOSE
06-feb-25	MEDIOCONTR	MEDIO DE CONTRASTE	UE Urgencias adulto	LOBATO POLO, JAVIER MAURICIO
06-feb-25	883101	RESONANCIA MAGNETICA DE CEREBRO	UE Urgencias adulto	LOBATO POLO, JAVIER MAURICIO
06-feb-25	903111	ACIDO LACTICO [L-LACTATO] AUTOMATIZADO	UE Urgencias adulto	MORALES LOPEZ, AURA MARCELA
06-feb-25	903813	CLORO	UE Urgencias adulto	MORALES LOPEZ, AURA MARCELA
06-feb-25	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS	UE Urgencias adulto	MORALES LOPEZ, AURA MARCELA
06-feb-25	903856	NITROGENO UREICO	UE Urgencias adulto	MORALES LOPEZ, AURA MARCELA
06-feb-25	903859	POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS	UE Urgencias adulto	MORALES LOPEZ, AURA MARCELA
06-feb-25	903864	SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS	UE Urgencias adulto	MORALES LOPEZ, AURA MARCELA
06-feb-25	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS IN	UE Urgencias adulto	MORALES LOPEZ, AURA MARCELA
06-feb-25	903839	GASES ARTERIALES (EN REPOSO O EN EJERCICIO)	UE Urgencias adulto	MORALES LOPEZ, AURA MARCELA
06-feb-25	903883-001	GLUCOSA SEMIAUTOMATIZADA [GLUCOMETRIA] CU	UE Urgencias adulto	GOMEZ CORDOBA, MARIA JOSE
06-feb-25	898807-006	ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE MARCACION INMUNOHISTOQUIMICA BASICA (IDH1-R132)	UE Urgencias adulto	LOBATO POLO, JAVIER MAURICIO
06-feb-25	898112	ESTUDIO DE ONCOGENES EN BIOPSIA	UE Urgencias adulto	LOBATO POLO, JAVIER MAURICIO
06-feb-25	898201	ESTUDIO DE COLORACION BASICA EN ESPECIMEN DE RECONOCIMIENTO	UE Urgencias adulto	LOBATO POLO, JAVIER MAURICIO
06-feb-25	898807-005	ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO DE MARCACION INMUNOHISTOQUIMICA BASICA (ESPECIFICO)	UE Urgencias adulto	LOBATO POLO, JAVIER MAURICIO
06-feb-25	898808	ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO EN BIOPSIA POR TINCION HISTOQUIMICA (ESPECIFICO)	UE Urgencias adulto	LOBATO POLO, JAVIER MAURICIO
06-feb-25	898808	ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO EN BIOPSIA POR TINCION HISTOQUIMICA (ESPECIFICO)	UE Urgencias adulto	LOBATO POLO, JAVIER MAURICIO

06-feb-25	898808	ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO EN BIOPSIA POR TINCION HISTOQUIMICA (ESPECIFICO)	UE Urgencias adulto	LOBATO POLO, JAVIER MAURICIO
06-feb-25	890408	INTERCONSULTA POR PSICOLOGIA	UE Urgencias adulto	HERNANDEZ TORO, ANDRES FELIPE
06-feb-25	890409-009	TAMIZAJE PSICOSOCIAL	UE Urgencias adulto	GONZALEZ GOMEZ, JUAN DAVID

Prescripciones

Fecha	Medicamento	Dosis	Unidad	Vía	Ciclo	Responsable
30-ene-25	DEXAMETASONA FOSFATO INY 8MG/2ML	8	MG	INTRAVENOSA	C/8H	ESTRADA MESA, MARIA MANUELA
30-ene-25	IVERMECTINA 6MG/ML FCO X 5ML GOTAS	50	GTA	ORAL	DOUNICA	ESTRADA MESA, MARIA MANUELA
01-feb-25	POLIETILENGLICOL 3350 (SIN ELECTROLITOS) FCO X160G	17	G	ORAL	C/8H	MERA JIMENEZ, JUAN JOSE
03-feb-25	DEXAMETASONA FOSFATO INY 8MG/2ML	4	MG	INTRAVENOSA	C/8H	LOBATO POLO, JAVIER MAURICIO
05-feb-25	MUPIROCINA UNGUENTO 2% TBO X 15G	15	G	TOPICA	DOUNICA	POLANCO ROA, DAVID
05-feb-25	CLORURO DE SODIO 7,5% X 100ML (SLN HIPERTÓNICA)	100	ML	INTRAVENOSA	DOUNICA	SANCHEZ VELEZ, BEATRIZ ELENA
05-feb-25	CLINDAMICINA 600MG/4 ML SOL INYECTABLE	900	MG	INTRAVENOSA	DOUNICA	POLANCO ROA, DAVID
05-feb-25	CLINDAMICINA 600MG/4 ML SOL INYECTABLE	600	MG	INTRAVENOSA	DOUNICA	CRISTANCHO TORRES, LAURA
05-feb-25	CEFTRIAXONA 1000 MG VIAL	2000	MG	INTRAVENOSA	DOUNICA	POLANCO ROA, DAVID
05-feb-25	DEXAMETASONA FOSFATO INY 8MG/2ML	4	MG	INTRAVENOSA	C/8H	MORALES LOPEZ, AURA MARCELA
05-feb-25	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML SOLUCION INYECTABLE	10	MG	INTRAVENOSA	C/8H	MORALES LOPEZ, AURA MARCELA
05-feb-25	DIPIRONA SOL INY 2.5G/5ML AMPOLLA	1250	MG	INTRAVENOSA	C/8H	MORALES LOPEZ, AURA MARCELA
05-feb-25	HIDROMORFONA 0.2 MG/ML JG X 5 ML	1	MG	INTRAVENOSA	DOUNICA	SANCHEZ VELEZ, BEATRIZ ELENA
05-feb-25	NEFOPAM CLORHIDRATO 20MG AMPX2ML	20	MG	INTRAVENOSA	DOUNICA	SANCHEZ VELEZ, BEATRIZ ELENA
05-feb-25	ONDANSETRON 8MG/4ML AMP 4ML	8	MG	INTRAVENOSA	DOUNICA	SANCHEZ VELEZ, BEATRIZ ELENA
05-feb-25	NOREPINEFRINA 4MG/4ML AMPOLLA	4	MG	INTRAVENOSA	DOUNICA	SANCHEZ VELEZ, BEATRIZ ELENA
05-feb-25	BROMURO DE ROCURONIO 50MG/5ML FRASCO X 5ML	100	MG	INTRAVENOSA	DOUNICA	SANCHEZ VELEZ, BEATRIZ ELENA
05-feb-25	PROPOFOL 10MG/ML X FCO 20ML	200	MG	INTRAVENOSA	DOUNICA	SANCHEZ VELEZ, BEATRIZ ELENA
05-feb-25	ATROPINA SULFATO SOL INYE 1MG/ML	1	MG	INTRAVENOSA	DOUNICA	SANCHEZ VELEZ, BEATRIZ ELENA
05-feb-25	ADRENALINA HCL 1 MG/ML AMP 1ML	1	MG	INTRAVENOSA	DOUNICA	SANCHEZ VELEZ, BEATRIZ ELENA
05-feb-25	DEXAMETASONA FOSFATO INY 8MG/2ML	8	MG	INTRAVENOSA	DOUNICA	SANCHEZ VELEZ, BEATRIZ ELENA
05-feb-25	REMIFENTANILO CLORHIDRATO JG PRELLENA 20MCG/ML X 50ML	1000	MCG	INTRAVENOSA	DOUNICA	SANCHEZ VELEZ, BEATRIZ ELENA
05-feb-25	ACIDO TRANEXAMICO 500MG/5ML AMP 5ML	1000	MG	INTRAVENOSA	DOUNICA	SANCHEZ VELEZ, BEATRIZ ELENA
05-feb-25	FENTANILO JERINGA PRELLENA 50 MCG/ML X 2ML	100	MCG	INTRAVENOSA	DOUNICA	SANCHEZ VELEZ, BEATRIZ ELENA
05-feb-25	DICLOFENACO SODICO 75 MG/ 3 ML	75	MG	INTRAVENOSA	DOUNICA	SANCHEZ VELEZ, BEATRIZ ELENA
05-feb-25	NORADRENALINA JG 8MCG/ML X 10 ML	80	MCG	INTRAVENOSA	DOUNICA	SANCHEZ VELEZ, BEATRIZ ELENA
05-feb-25	MIDAZOLAM JERINGA PRELLENA 1 MG/ML X 3 ML	3	MG	INTRAVENOSA	DOUNICA	SANCHEZ VELEZ, BEATRIZ ELENA
05-feb-25	LIDOCAINA JERINGA PRELLENA 20MG/ML X 3ML	60	MG	INTRAVENOSA	DOUNICA	SANCHEZ VELEZ, BEATRIZ ELENA
05-feb-25	DIPIRONA SOL INY 2.5G/5ML AMPOLLA	2000	MG	INTRAVENOSA	DOUNICA	SANCHEZ VELEZ, BEATRIZ ELENA
05-feb-25	BUPIVACAINA 5MG/EPINEFRINA BITAR 9,1MCG/ML AMP 10ML	50	MG	PARENTERAL	DOUNICA	SANCHEZ VELEZ, BEATRIZ ELENA
05-feb-25	DEXAMETASONA FOSFATO INY 8MG/2ML	4	MG	INTRAVENOSA	C/8H	POLANCO ROA, DAVID
06-feb-25	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML SOLUCION INYECTABLE	10	MG	INTRAVENOSA	C/8H	MEDINA, CAMILO ANDRES
06-feb-25	ACETAMINOFEN 500MG TAB	1000	MG	ORAL	C/8H	MEDINA, CAMILO ANDRES
06-feb-25	POLIETILENGLICOL 3350 (SIN ELECTROLITOS) FCO X160G	17	G	ORAL	C/8H	MEDINA, CAMILO ANDRES
06-feb-25	DEXAMETASONA FOSFATO INY 8MG/2ML	4	MG	INTRAVENOSA	C/8H	MEDINA, CAMILO ANDRES
06-feb-25	DEXAMETASONA FOSFATO INY 8MG/2ML	8	MG	INTRAVENOSA	C/8H	MORALES LOPEZ, AURA MARCELA
06-feb-25	SOLUCION HARTMAN BOL 1000ML	500	ML	INTRAVENOSA	DOUNICA	MORALES LOPEZ, AURA MARCELA
06-feb-25	SOLUCION HARTMAN BOL 1000ML	80	ML	INTRAVENOSA	C/1H	MORALES LOPEZ, AURA MARCELA
06-feb-25	OMEPRAZOL SODICO 40 MG VIAL	40	MG	INTRAVENOSA	C/24H	MORALES LOPEZ, AURA MARCELA
07-feb-25	OMEPRAZOL SODICO 40 MG VIAL	40	MG	INTRAVENOSA	C/24H	MEDINA, CAMILO ANDRES
07-feb-25	DIPIRONA SOL INY 2.5G/5ML AMPOLLA	1250	MG	INTRAVENOSA	C/8H	MEDINA, CAMILO ANDRES

Evoluciones Médicas

Fecha: 30-ene-25	Hora: 17:38:41	Tipo de Evolución:Interconsulta en Urgencias

NEUROCIRUGÍA INTERCONSULTA

MOTIVO DE CONSULTA:
"TENGO DEBILIDAD EN LA PARTE DERECHA DEL CUERPO"

ENFERMEDAD ACTUAL:
PACIENTE CON ANTECEDENTE DE GLIOBLASTOMA TALÁMICO IZQUIERDO, RESECADO EL 12/05/2023, RECIBIÓ TRATAMIENTO CON TEMOZOLAMIDA Y RADIOTERAPIA EN CONCOMITANCIA POR 6 MESES HASTA 2024. AHORA ACUDE A LA CONSULTA DE NEUROCIRUGÍA PORQUE DESDE HACE 1 MES TIENE DEBILIDAD EN EL HEMICUERPO DERECHO, APORTA RESONANCIA MAGNÉTICA CONTRASTADA DEL 25/01/2025 QUE DOCUMENTA LESIÓN REALZANTE EN EL TÁLAMO IZQUIERDO CON EDEMA VASOGÉNICO FRONTOPARIETAL IZQUIERDO, POR LO CUÁL SE DERIVA AL SERVICIO DE URGENCIAS. SOLICITAN INTERCONSULTA.

ANTECEDENTES:
PATOLÓGICOS: GLIOBLASTOMA MULTIFORME TALÁMICO IZQUIERDO, POP RESECCIÓN 12 DE MAYO DE 2023, CULMINÓ RADIOTERAPIA EN CONCOMITANCIA CON TEMOZOLADMIDA EL 3/8/2023. TEMOZOLAMIDA POR 6 MESES MÁS TERMINÓ EN NOVIMEBRE 2024
PATOLOGÍA: CÉLULAS TUMORALES POSITIVAS PARA GFAP, OLIG2 Y S100. P53 NO SOBRE-EXPRESADO. ÍNDICE DE PROLIFERACIÓN MEDIDO MEDIANTE KI67 ES DEL 20-25%.
IDH: CÉLULAS TUMORALES NEGATIVAS PARA IDH (R132H).
- GLIOBLASTOMA DE TIPO IDH NATIVO (GRADO 4 DE LA OMS) P53 NO SOBRE EXPRESADO.
MIOMATOSIS UTERINA, OVARIOS POLIQUÍSTICOS.
-ALERGIAS: NIEGA
-QUIRÚRGICOS: BIOPSIA ESTEREOTÁXICA EL 20.04.2023
-TÓXICOS: NIEGA
-FAMILIARES: NIEGA
-INMUNOLÓGICOS: 1 DOSIS PARA SARS-COV 2

OBJETIVO
SIGNOS VITALES:
TEMPERATURA: 36º CENTÍGRADOS
FRECUENCIA CARDIACA: 85 LATIDOS POR MINUTO
FRECUENCIA RESPIRATORIA: 18 RESPIRACIONES POR MINUTO
TENSIÓN ARTERIAL: 128/77 MMHG
SATURACIÓN: 94 %

ALERTA, ORIENTADA

LENGUAJE FLUIDO, COMPRENDE, NO MINA, REPITE
PUPILAS 3MM, REACTIVAS, MOVIMIENTOS EXTRAOCULARES CONSERVADOS
CAMPIMETRÍA POR CONFRONTACIÓN SIN ALTERACIONES
HEMIPARESIA DERECHA BRAQUIAL 4/5 y crural 3/5
REFLEJOS ++ marcha PARÉTICA
SENSIBILIDAD SIN ALTERACIONES
BABINSKI DERECHO

* RESONANCIA CEREBRAL CONTRASTADA (25.01.2025)
SE OBSERVA LESIÓN REALZANTE CON EL MEDIO DE CONTRASTE EN TÁLAMO IZQUIERDO. EN T2 SE VE RELATIVAMENTE BIEN DELIMITADO, EN LOS MAPAS DE PERFUSIÓN MUESTRA VASCULARIZACIÓN. ASOCIADO A UN EDEMA VASOGÉNICO FRONTO PARIETAL EXTENSO (LAS CARACTERÍSTICAS DE LA LESIÓN PREQUIRÚRGICA NO MOSTRABA EDEMA SIGNIFICATIVO).

ANÁLISIS:
PACIENTE CON ANTECEDENTE DE GLIOBLASTOMA TALÁMICO, CON SÍNDROME PIRAMIDAL DERECHO Y RESONANCIA MAGNÉTICA CEREBRAL CON CAMBIOS POR RADIACIÓN VERSUS RECIDIVA TUMORAL, POR LO CUÁL SE INDICA REALIZACIÓN DE ESPECTROSCOPIA DE FORMA URGENTE. REQUIERE MANEJO CON ESTEROIDE SISTÉMICO. SE HOSPITALIZA A CARGO DE NEUROCIRUGÍA, CON RESULTADOS DE ESPECTROSCOPÍA SE DEFINIRÁ MANEJO. SE EXPLICA A PACIENTE Y FAMILIAR. SE RESUELVEN DUDAS.

RAFAEL NÚÑEZ, RESIDENTE NEUROCIRUGÍA

Ayudas diagnó. ult. 24 horas: Anormal: X
Descripción de la anormalidad:
SOSPECHA DE LESIÓN RECIDIVANTE VERSUS CAMBIOS POST RADIACIÓN

Responsable:	LOBATO POLO, JAVIER MAURICIO	NEUROCIRUGIA	N. Identificación:	0091481284
RM:	59500	Válido como firma electrónica		

Evoluciones Médicas

Fecha:	30-ene-25	Hora:	18:24:53	Tipo de Evolución:Valoración en sala de observación urge

OBSERVACION URGENCIAS
KAROL GABRIELA VELEZ ROSERO

DIAGNOSTICO
GLIOBLASTOMA TALAMICO IZQUIERDO
RECAIDA TUMORAL

ANTECEDENTES:
PATOLÓGICOS: GLIOBLASTOMA MULTIFORME TALÁMICO IZQUIERDO, POP RESECCIÓN 12 DE MAYO DE 2023, CULMINÓ RADIOTERAPIA EN CONCOMITANCIA CON TEMOZOLADMIDA EL 3/8/2023. TEMOZOLAMIDA POR 6 MESES MÁS TERMINÓ EN NOVIMEBRE 2024
PATOLOGÍA: CÉLULAS TUMORALES POSITIVAS PARA GFAP, OLIG2 Y S100. P53 NO SOBRE-EXPRESADO. ÍNDICE DE PROLIFERACIÓN MEDIDO MEDIANTE KI67 ES DEL 20-25%.
IDH: CÉLULAS TUMORALES NEGATIVAS PARA IDH (R132H).
- GLIOBLASTOMA DE TIPO IDH NATIVO (GRADO 4 DE LA OMS) P53 NO SOBRE EXPRESADO.
MIOMATOSIS UTERINA, OVARIOS POLIQUÍSTICOS.
-ALERGIAS: NIEGA
-QUIRÚRGICOS: BIOPSIA ESTEREOTÁXICA EL 20.04.2023
-TÓXICOS: NIEGA
-FAMILIARES: NIEGA

-INMUNOLÓGICOS: 1 DOSIS PARA SARS-COV 2

ALERTA, ORIENTADA
LENGUAJE FLUIDO, SIN PARAFASIAS, COMPRENDE BIEN
PUPILAS 3MM, REACTIVAS, MOVIMIENTOS EXTRAOCULARES CONSERVADOS
CAMPIMETRÍA POR CONFRONTACIÓN SIN ALTERACIONES
HEMIPARESIA BRAQUIOCRURAL DERECHA 4/5
HIPORREFLEXIA GENERALIZADA
SENSIBILIDAD SIN ALTERACIONES
BABINSKI DERECHO
HOFFMANN Y TROMNER AUSENTES
DISMETRÍA Y DISDIADOCOCINESIAS AUSENTES

* RESONANCIA CEREBRAL CONTRASTADA (25.01.2025)
SE OBSERVA LESIÓN REALZANTE CON EL MEDIO DE CONTRASTE EN TÁLAMO IZQUIERDO. EN T2 SE VE RELATIVAMENTE BIEN DELIMITADO, EN LOS MAPAS DE PERFUSIÓN MUESTRA VASCULARIZACIÓN. ASOCIADO A UN EDEMA VASOGÉNICO FRONTO PARIETAL EXTENSO (LAS CARACTERÍSTICAS DE LA LESIÓN PREQUIRÚRGICA NO MOSTRABA EDEMA SIGNIFICATIVO).

ANÁLISIS:
PACIENTE CON ANTECEDENTE DE GLIOBLASTOMA TALÁMICO, CON SÍNDROME PIRAMIDAL DERECHO Y RESONANCIA MAGNÉTICA CEREBRAL CON CAMBIOS POR RADIACIÓN VERSUS RECIDIVA TUMORAL, POR LO CUÁL SE INDICA REALIZACIÓN DE ESPECTROSCOPIA DE FORMA URGENTE. REQUIERE MANEJO CON ESTEROIDE SISTÉMICO. SE HOSPITALIZA A CARGO DE NEUROCIRUGÍA, CON RESULTADOS DE ESPECTROSCOPÍA SE DEFINIRÁ MANEJO.

Ayudas diagnó. ult. 24 horas:	Anormal:	X	
Descripción de la anormalidad: SOSPECHA DE LESIÓN RECIDIVANTE VERSUS CAMBIOS POST RADIACIÓN			
Responsable: ESTRADA MESA, MARIA MANUELA	MEDICINA GENERAL	N. Identificación:	1144146023
RM: 7662232014	Válido como firma electrónica		

Evoluciones Médicas

Fecha:	31-ene-25	Hora:	06:24:31	Tipo de Evolución:	Manejo Diario

NEUROCIRUGÍA

DIAGNÓSTICOS:
- RESECCIÓN LESIÓN TALÁMICA IZQUIERDA 12.05.2023
-- PATOLOGÍA: GLIOBLASTOMA IDH NATIVO KI 20-25%

SUBJETIVO: PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN, REFIERE MEJORÍA DE LA DEBILIDAD EN HEMICUERPO DERECHO POSTERIOR A INICOI DE ESTEROIDE

OBJETIVO
SIGNOS VITALES:
TEMPERATURA: 35.3º CENTÍGRADOS
FRECUENCIA CARDIACA: 77 LATIDOS POR MINUTO
FRECUENCIA RESPIRATORIA: 19 RESPIRACIONES POR MINUTO
TENSIÓN ARTERIAL: 89/52 MMHG
SATURACIÓN: 99%

ALERTA, ORIENTADA
LENGUAJE FLUIDO, COMPRENDE, NO MINA, REPITE
PUPILAS 3MM, REACTIVAS, MOVIMIENTOS EXTRAOCULARES CONSERVADOS
CAMPIMETRÍA POR CONFRONTACIÓN SIN ALTERACIONES
HEMIPARESIA DERECHA PREDOMINIO BRAQUIAL 4/5
REFLEJOS ++
SENSIBILIDAD SIN ALTERACIONES
BABINSKI DERECHO

PARACLINICOS:
30.01.2025 LEUCOCITOS 7680 NEUTROFILOS 4850 LINFOCITOS 2450 HEMOGLOBINA 15.1 HEMATOCRITO 44.6 PLAQUETAS 302 NITROGENO UREICO 12.4 CREATININA 0.67 SODIO 137.9 POTASIO 3.57

ANÁLISIS Y PLAN: PACIENTE CON ANTECEDENTE DE GLIOBLASTOMA TALÁMICO, CON SÍNDROME PIRAMIDAL DERECHO Y RESONANCIA MAGNÉTICA CEREBRAL CON LESIÓN TALÁMICA IZQUIERDA A DEFINIR SI SE TRATA DE CAMBIOS POR RADIACIÓN VERSUS RECIDIVA TUMORAL, POR LO CUÁL SE SOLICITÓ ESPECTROSCOPIA LA CUAL ESTÁ PENDIENTE. POR EL MOMENTO CONTINUA MANEJO CON ESTEROIDE.
SE INFORMA A PACIENTE Y FAMILIAR

ANA MARIA ULLOA, RESIDENTE NEUROCIRUGÍA

Ayudas diagnó. ult. 24 horas:	Anormal:	X	
Descripción de la anormalidad: SOSPECHA DE LESIÓN RECIDIVANTE VERSUS CAMBIOS POST RADIACIÓN TALAMICO IZQUIERDO			
Responsable: LOBATO POLO, JAVIER MAURICIO	NEUROCIRUGIA	N. Identificación:	0091481284
RM: 59500	Válido como firma electrónica		

Evoluciones Médicas

Fecha:	01-feb-25	Hora:	12:48:01	Tipo de Evolución:	Manejo Diario

NEUROCIRUGÍA

DIAGNÓSTICOS:
- RESECCIÓN LESIÓN TALÁMICA IZQUIERDA 12.05.2023
-- PATOLOGÍA: GLIOBLASTOMA IDH NATIVO KI 20-25%

SUBJETIVO: PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN, HA MEJORADO LA FUERZA

OBJETIVO
SIGNOS VITALES:
TEMPERATURA: 35.7º CENTÍGRADOS
FRECUENCIA CARDIACA: 73 LATIDOS POR MINUTO
FRECUENCIA RESPIRATORIA: 20 RESPIRACIONES POR MINUTO
TENSIÓN ARTERIAL: 114/79 MMHG
SATURACIÓN: 100%

ALERTA, ORIENTADA
LENGUAJE FLUIDO, COMPRENDE, NO MINA, REPITE
PUPILAS 3MM, REACTIVAS, MOVIMIENTOS EXTRAOCULARES CONSERVADOS
CAMPIMETRÍA POR CONFRONTACIÓN SIN ALTERACIONES
MONOPARESIA MIEMBRO SUPERIOR DERECHO FUERZA 4+/5
REFLEJOS ++
SENSIBILIDAD SIN ALTERACIONES
BABINSKI DERECHO

ANÁLISIS Y PLAN: PACIENTE CON ANTECEDENTE DE GLIOBLASTOMA TALÁMICO, CON SÍNDROME PIRAMIDAL DERECHO Y RESONANCIA MAGNÉTICA CEREBRAL CON LESIÓN TALÁMICA IZQUIERDA A DEFINIR SI SE TRATA DE CAMBIOS DE RADIONECROSIS POR RADIACIÓN VERSUS RECIDIVA TUMORAL. SE REALIZÓ ESPECTROSCOPIA EL DÍA DE AYER SIN EMBARGO ESTÁ PENDIENTE PROCESAMIENTO DE ÉSTE Y RESULTADO CON LO CUAL SE DEFINIRÁ CONDUCTA.
POR EL MOMENTO CONTINUA MANEJO CON ESTEROIDE SISTÉMICO.
SE INFORMA A PACIENTE Y FAMILIAR

ANA MARIA ULLOA, RESIDENTE NEUROCIRUGÍA

Ayudas diagnó. ult. 24 horas:	Sin estudios pendientes:	X	
Responsable:	LOBATO POLO, JAVIER MAURICIO	NEUROCIRUGIA	N. Identificación: 0091481284
RM:	59500	Válido como firma electrónica	

Evoluciones Médicas

Fecha:	02-feb-25	Hora:	17:03:00	Tipo de Evolución:	Manejo Diario

NEUROCIRUGÍA

DIAGNÓSTICOS:
- RESECCIÓN LESIÓN TALÁMICA IZQUIERDA 12.05.2023
-- PATOLOGÍA: GLIOBLASTOMA IDH NATIVO KI 20-25%

SUBJETIVO: PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN, NIEGA CEFALEA. TOLERA VIA ORAL

OBJETIVO
SIGNOS VITALES:
TEMPERATURA: 36.4º CENTÍGRADOS
FRECUENCIA CARDIACA: 86 LATIDOS POR MINUTO
FRECUENCIA RESPIRATORIA: 17 RESPIRACIONES POR MINUTO
TENSIÓN ARTERIAL: 113/74 MMHG
SATURACIÓN: 98%

ALERTA, ORIENTADA
LENGUAJE FLUIDO, COMPRENDE, NO MINA, REPITE
PUPILAS 3MM, REACTIVAS, MOVIMIENTOS EXTRAOCULARES CONSERVADOS
CAMPIMETRÍA POR CONFRONTACIÓN SIN ALTERACIONES
HEMIPARESIA DERECHA 4/5
REFLEJOS ++
SENSIBILIDAD SIN ALTERACIONES
BABINSKI DERECHO

ANÁLISIS Y PLAN: PACIENTE CON ANTECEDENTE DE GLIOBLASTOMA TALÁMICO, CON SÍNDROME PIRAMIDAL DERECHO. TIENE RESONANCIA MAGNÉTICA CEREBRAL CON LESIÓN TALÁMICA IZQUIERDA A DEFINIR SI SE TRATA DE CAMBIOS DE RADIONECROSIS VERSUS RECIDIVA TUMORAL. ESTAMOS ATENTOS A REPORTE DE ESPECTROSCOPIA PARA DEFINIR CONDUCTA.
CONTINUA MANEJO CON ESTEROIDE SISTÉMICO.
SE INFORMA A PACIENTE Y FAMILIAR

ANA MARIA ULLOA, RESIDENTE NEUROCIRUGÍA

Ayudas diagnó. ult. 24 horas:	Sin estudios pendientes:	X	
Responsable:	LOBATO POLO, JAVIER MAURICIO	NEUROCIRUGIA	N. Identificación: 0091481284
RM:	59500	Válido como firma electrónica	

Evoluciones Médicas

Fecha: 03-feb-25	Hora: 11:14:38	Tipo de Evolución:Manejo Diario

NEUROCIRUGÍA

DIAGNÓSTICOS:
- RESECCIÓN LESIÓN TALÁMICA IZQUIERDA 12.05.2023
-- PATOLOGÍA: GLIOBLASTOMA IDH NATIVO KI 20-25%

SUBJETIVO: PACIENTE REFIERE DESDE AYER CON EMPEORAMIENTO DE LA DEBILIDAD EN HEMICUERPO DERECHO Y DE LA CARA. CEFALEA MODULADA

OBJETIVO
SIGNOS VITALES:
TEMPERATURA: 36.4º CENTÍGRADOS
FRECUENCIA CARDIACA: 101 LATIDOS POR MINUTO
FRECUENCIA RESPIRATORIA: 19 RESPIRACIONES POR MINUTO
TENSIÓN ARTERIAL: 110/62 MMHG
SATURACIÓN: 98%

ALERTA, ORIENTADA
LENGUAJE FLUIDO, COMPRENDE, NO MINA, REPITE
PUPILAS 3MM, REACTIVAS, MOVIMIENTOS EXTRAOCULARES CONSERVADOS
CAMPIMETRÍA POR CONFRONTACIÓN SIN ALTERACIONES
PARALISIS FACIAL CENTRAL DERECHA
HEMIPARESIA DERECHA FUERZA 4/5 PROXIMAL Y 3/5 DISTAL EN MIEMBRO SUPERIOR Y 4+/5 EN MIEMBRO INFERIR
FUERZA 5/5 EN HEMICUERO IZQUIERDO
REFLEJOS ++
SENSIBILIDAD SIN ALTERACIONES
BABINSKI DERECHO

IMAGENES:
- ESPECTROSCOPIA 31.12.2024: SE EVIDENCIAN PICOS DE COLINA Y AUMENTO DE LA RELACION COLINA- NAA EN AREA CON REALCE CON EL MEDIO DE CONTRASTE TALAMICA IZQUIERDA, SUGESTIVO DE RECIDIVA TUMORAL. LAS CURVAS ESPECTRALES EN LA ZONA DE EDEMA NO SON COMPATIBLES CON LESION TUMORAL

ANÁLISIS Y PLAN: PACIENTE CON ANTECEDENTE DE GLIOBLASTOMA TALÁMICO, IDH NATIVO, CON SÍNDROME PIRAMIDAL DERECHO Y EVIDENCIA EN LA ESPECTROSCOPIA DE CURVAS ESPECTRALES SUGESTIVAS DE RECIDIVA TUMORAL, SIN EVIDENCIA DE LESION TUMORAL EN ZONA DE EDEMA. EN EL MOMENTO CON HEMIPARESIA FACIOBRAQUICRURAL DERECHA, SIN ALTERACION DEL ESTADO DE CONCIENCIA. SE DISCUTE CASO EN JUNTA NEUROQUIRURGICA, DONDE SE DEFINE QUE DADO QUE SE TRATA DE UNA LESION BIEN DELIMITADA Y TENIENDO EN CUENTA LA RESPUESTA AL MANEJO PREVIO, SE BENEFICIA DE CIRUGIA PARA RESECCION DE LESION RECIDIVATE POR CRANEOTOMIA GUIADA POR NEURONAVEGACION Y ECOGRAFIA INTRAOPERATORIA. SE REALIZAN ORDENES QUIRURGICAS. SE REALIZARA EL PROCEDIMIENTO POSIBLEMENTE EL PROXIMO VIERNES. SE EXPLICA A PACIENTE LAS METAS Y RIESGOS DEL PROCEDIMIENTO. SE AJUSTA DOSIS DE DEXAMETASONA (4MG CADA 8 HORAS)

XIMENA SERUR
RESIDENTE NEUROCIRUGÍA

Ayudas diagnó. ult. 24 horas: Anormal: X

Descripción de la anormalidad:
RECIDIVA TUMORAL

Responsable:	LOBATO POLO, JAVIER MAURICIO	NEUROCIRUGIA	N. Identificación:	0091481284
RM:	59500	Válido como firma electrónica		

Evoluciones Médicas

Fecha: 04-feb-25	Hora: 05:49:22	Tipo de Evolución:Manejo Diario

NEUROCIRUGÍA

DIAGNÓSTICOS:
- RESECCIÓN LESIÓN TALÁMICA IZQUIERDA 12.05.2023
-- PATOLOGÍA: GLIOBLASTOMA IDH NATIVO KI 20-25%
- RECIDIVA TUMORAL TALÁMICA IZQUIERDA

SUBJETIVO: PACIENTE REFIERE MAYOR DEBILIDAD EN MIEMBRO SUERIOR IZQUIERDO

OBJETIVO
SIGNOS VITALES:
TEMPERATURA: 36º CENTÍGRADOS
FRECUENCIA CARDIACA: 70 LATIDOS POR MINUTO
FRECUENCIA RESPIRATORIA: 18 RESPIRACIONES POR MINUTO
TENSIÓN ARTERIAL: 110/64 MMHG
SATURACIÓN: 98%

ALERTA, ORIENTADA
LENGUAJE FLUIDO, COMPRENDE, NOMINA, REPITE
PUPILAS 3MM, REACTIVAS, MOVIMIENTOS EXTRAOCULARES CONSERVADOS
CAMPIMETRÍA POR CONFRONTACIÓN SIN ALTERACIONES
PARESIA FACIAL CENTRAL DERECHA
HEMIPARESIA DERECHA FUERZA MIEBRO SUPERIOR 3/5 Y MIEMBRO INFERIOR 4+/5
FUERZA 5/5 EN HEMICUERO IZQUIERDO

REFLEJOS ++
SENSIBILIDAD SIN ALTERACIONES
BABINSKI DERECHO

ANÁLISIS Y PLAN: PACIENTE CON ANTECEDENTE DE GLIOBLASTOMA TALÁMICO, IDH NATIVO, CON SÍNDROME PIRAMIDAL DERECHO Y EVIDENCIA EN LA ESPECTROSCOPIA DE CURVAS ESPECTRALES SUGESTIVAS DE RECIDIVA TUMORAL. PACIENTE CON INDICACIÓN DE MANEJO QUIRÚRGICO EL CUAL SE REALIZARÁ EL VIERNES 07.02.2025 EN SEDE LIMONAR. PENDIENTE VALORACIÓN NEUROPSICOLÓGICA Y TIEMPOS DE COAGULACIÓN YA SOLICITADOS.
POR EL MOMENTO CONTINUA MANEJO CON ESTEROIDES.
SE INFORMA A PACIENTE Y FAMILIAR

ANA MARIA ULLOA, RESIDENTE NEUROCIRUGÍA

Ayudas diagnó. ult. 24 horas:	Sin estudios pendientes:	X	
Responsable:	BELTRAN OSORIO, LUIS DAVID	NEUROCIRUGIA	N. Identificación: 1123631240
RM:	1123631240	Válido como firma electrónica	

Evoluciones Médicas

Fecha:	04-feb-25	Hora:	21:26:53	Tipo de Evolución:	Consulta de ingreso de paciente a piso

NOTA DE INGRESO UNIDAD DE HOSPITALIZACION

KAROL GABRIELA VELEZ ROSERO

Número Identificación: 1193103725

DIAGNÓSTICOS:
- RESECCIÓN LESIÓN TALÁMICA IZQUIERDA 12.05.2023
-- PATOLOGÍA: GLIOBLASTOMA IDH NATIVO KI 20-25%
- RECIDIVA TUMORAL TALÁMICA IZQUIERDA

SUBJETIVO: PACIENTE REFIERE MAYOR DEBILIDAD EN MIEMBRO SUERIOR IZQUIERDO

OBJETIVO: PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, SIN SIGNOS DE SIRS, DIFICULTAD RESPIRATORIA O HIPOPERFUSION, SIN SOPORTE DE OXIGENO O HEMODINAMICO, SIN SONDAS DE NINGUN TIPO, CON DREN BLACKE DE SITIO QUIRURGICO

OBJETIVO
SIGNOS VITALES:
TEMPERATURA: 36º CENTÍGRADOS
FRECUENCIA CARDIACA: 70 LATIDOS POR MINUTO
FRECUENCIA RESPIRATORIA: 18 RESPIRACIONES POR MINUTO
TENSIÓN ARTERIAL: 110/64 MMHG
SATURACIÓN: 98%

ALERTA, ORIENTADA
LENGUAJE FLUIDO, COMPRENDE, NOMINA, REPITE
PUPILAS 3MM, REACTIVAS, MOVIMIENTOS EXTRAOCULARES CONSERVADOS
CAMPIMETRÍA POR CONFRONTACIÓN SIN ALTERACIONES
PARESIA FACIAL CENTRAL DERECHA
HEMIPARESIA DERECHA FUERZA MIEBRO SUPERIOR 3/5 Y MIEMBRO INFERIOR 4+/5
RUIDOS CARDIACOSRITMICOS Y REGULARES
MURMULLO VESICULAR CONSERVADO
ABDOMEN BLANDO Y DEPRESIBLE NO DOLOROSO A LA PALPACION, NO SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL
FUERZA 5/5 EN HEMICUERO IZQUIERDO
REFLEJOS ++
SENSIBILIDAD SIN ALTERACIONES
BABINSKI DERECHO

ANÁLISIS Y PLAN: PACIENTE CON ANTECEDENTE DE GLIOBLASTOMA TALÁMICO, IDH NATIVO, CON SÍNDROME PIRAMIDAL DERECHO Y EVIDENCIA EN LA ESPECTROSCOPIA DE CURVAS ESPECTRALES SUGESTIVAS DE RECIDIVA TUMORAL. PACIENTE CON INDICACIÓN DE MANEJO QUIRÚRGICO EL CUAL SE REALIZARÁ EL VIERNES 07.02.2025 EN SEDE LIMONAR. PENDIENTE VALORACIÓN NEUROPSICOLÓGICA Y TIEMPOS DE COAGULACIÓN YA SOLICITADOS.
POR EL MOMENTO CONTINUA MANEJO CON ESTEROIDES.
SE INFORMA A PACIENTE Y FAMILIAR

PACIENTE CONTINUA BAJO VIGILANCIA CLINICA Y PARACLINICA A CARGO DE NEUROCIRUGIA
SE EXPLICA A PACIENTE Y FAMILIAR, REFIEREN ENTENDER Y ACEPTAR.
SE PREGUNTAN DUDAS SOBRE EL PROCESO DE HOSPITALAIZACION Y EGRESO, PACIENTE Y FAMILIAR ENTIENDEN Y ACEPTAN CONDUCTAS SOBRE EL PROCESO

NOTA DE CLASIFICACION DEL RIESGO
EL PACIENTE SE CLASIFICA COMO ALTO RIESGO DEBIDO A QUE EL PACIENTE
PRESENTA PATOLOGIA HEMATO ONCOLOGICA

Ayudas diagnó. ult. 24 horas:	Sin estudios pendientes:	X	
Responsable:	POLANCO ROA, DAVID	MEDICINA GENERAL	N. Identificación: 1144204725
RM:	1144204725	Válido como firma electrónica	

Evoluciones Médicas

Fecha: 05-feb-25	Hora: 05:27:26	Tipo de Evolución:Manejo Diario

NEUROCIRUGÍA

DIAGNÓSTICOS:
- RESECCIÓN LESIÓN TALÁMICA IZQUIERDA 12.05.2023
-- PATOLOGÍA: GLIOBLASTOMA IDH NATIVO KI 20-25%
- RECIDIVA TUMORAL TALÁMICA IZQUIERDA

SUBJETIVO: PASA BIEN LA NOCHE, SIN FIEBRE, NIEGA MAYOR DETERIORO MOTOR

OBJETIVO
SIGNOS VITALES:
TEMPERATURA: 35.8º CENTÍGRADOS
FRECUENCIA CARDIACA: 80 LATIDOS POR MINUTO
FRECUENCIA RESPIRATORIA: 19 RESPIRACIONES POR MINUTO
TENSIÓN ARTERIAL: 116/61 MMHG
SATURACIÓN: 92%

ALERTA, ORIENTADA
LENGUAJE FLUIDO, COMPRENDE, NOMINA, REPITE
PUPILAS 3MM, REACTIVAS, MOVIMIENTOS EXTRAOCULARES CONSERVADOS
CAMPIMETRÍA POR CONFRONTACIÓN SIN ALTERACIONES
PARESIA FACIAL CENTRAL DERECHA
HEMIPARESIA DERECHA FUERZA MIEBRO SUPERIOR 3/5 Y MIEMBRO INFERIOR 4+/5
FUERZA 5/5 EN HEMICUERO IZQUIERDO
REFLEJOS ++
SENSIBILIDAD SIN ALTERACIONES
BABINSKI DERECHO

PT 10.7 INR 0.98 PTT 28.9

ANÁLISIS Y PLAN: PACIENTE CON ANTECEDENTE DE GLIOBLASTOMA TALÁMICO, IDH NATIVO, CON SÍNDROME PIRAMIDAL DERECHO Y EVIDENCIA EN LA ESPECTROSCOPIA DE CURVAS ESPECTRALES SUGESTIVAS DE RECIDIVA TUMORAL. PACIENTE CON INDICACIÓN DE MANEJO QUIRÚRGICO EL CUAL SE REALIZARÁ EL DIA DE HOY. SE EXPLICA INDICACION, RIESOGS Y BENEFICIOS ASOCIADOS AL PROCEDIMIENTO. SE FIRMA CONSENTIMIENTO INFORMADO.

JUAN CAMILO ARIAS
RESIDENTE NEUROCIRUGÍA

Ayudas diagnó. ult. 24 horas:	Sin estudios pendientes:	X		
Responsable:	BELTRAN OSORIO, LUIS DAVID	NEUROCIRUGIA	N. Identificación:	1123631240
RM:	1123631240	Válido como firma electrónica		

Evoluciones Médicas

Fecha: 05-feb-25	Hora: 11:32:42	Tipo de Evolución:Evolución

RONDA DE CUIDADO INTERDISCIPLINARIA
RESECCIÓN LESIÓN TALÁMICA IZQUIERDA 12.05.2023
-- PATOLOGÍA: GLIOBLASTOMA IDH NATIVO KI 20-25%
- RECIDIVA TUMORAL TALÁMICA IZQUIERDA

Se realiza ronda interdisciplinaria compuesta por:
jefe de enfermería de turno, médico general, médico internista, nutrición, terapia física, terapia respiratoria, trabajo social, psicología, jefe asistencial, coordinador médico, químico farmacéutico. Se verifica y aclara al paciente y su familiar los siguientes aspectos:

Conocimiento del médico tratante: Neurocirugia

Conocimiento del diagnóstico y evolución de la enfermedad actual: Si
Conocimiento del plan de tratamiento: Si

Durante la ronda se identifican necesidades especiales en el paciente y
su familia.
Postoperatorio proximo -- Seguimiento por terapia fisica
Diagnostico oncologico -- Seguimiento por psicooncologia

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO PARA LA PLANIFICACION DEL ALTA.
Paciente con riesgo alto: Diagnostico oncologico

Dr. Andrés Felipe Hernández Toro
Especialista en Medicina Interna
Fundación Valle del Lili
RM: 1151940158

Ayudas diagnó. ult. 24 horas:	Sin estudios pendientes:	X		
Responsable:	HERNANDEZ TORO, ANDRES FELIPE	MEDICINA INTERNA	N. Identificación:	1151940158
RM:	1151940158	Válido como firma electrónica		

Evoluciones Médicas

Fecha: 05-feb-25	Hora: 12:05:25	Tipo de Evolución:Interconsulta por especialista

FISIATRIA
PACIENTE DE 23 AÑOS DE EDAD

DIAGNÓSTICOS:
- RESECCIÓN LESIÓN TALÁMICA IZQUIERDA 12.05.2023
-- PATOLOGÍA: GLIOBLASTOMA IDH NATIVO KI 20-25%
- RECIDIVA TUMORAL TALÁMICA IZQUIERDA

SUBJETIVO
ACOMPAÑADA POR FAMILIAR, REFIERE DEBILIDAD HEMICUERPO DERECHO, NIEGA DOLOR CONTROLADO, TOLERA LA VIA ORAL, HOY EN AYUNO POR PROCEDIMINETO QX EL DIA DE HOY, DEPOSICIONES Y DIURESIS +

AL EXAMEN FISICO
EN CAMA, ALERTA, TRANQUILA, COLABORADORA, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, SIMETRIA FACIAL, SIN COMPROMISO DE PARES CRANEANOS BAJOS, PUPILAS ISOCORTICAS NORMOREACTIVAS, MOVIMINETOS OCULARES EXTERNOS NOMRLAES, ABDOEMN BLANDO DEPRESIBLE, FUERZA MUSCULAR HEMICUYERPO IZQUIERDO, HEMIPARESIA DERECHA CON FUERZA 2/5 MIMEBRO SUPERIOR Y 4-/5 EN MIEMBRO INFERIOR, BABISKI DERECHO, NORMOREFLEXIA, SIN EDEMAS

ANALISIS Y PLAN
PACIENTE CON DEFICIENCIAS DEL SISTEMA INMUNOLOGICO, NEUROMUSCULAR,
REQUEIRE INICIAR PROCESO DE REHABILITACION

TERAPIA FISICA NEUROLOGICA / OCUPACIONAL
LIMITAR LAS COMPLICACIONES DEL REPOSO PROLONGADO
REEDUCACION MOTORA Y SENSITIVA
MANEJO DE PROPIOCPEICON Y COORDINACION
PATORNES FUNCIONALES
LIMITAR RETRACCIONES
EVITAR CONTRACTURAS
MODULAR DOLOR
TECNICAS DE FACILITACION NEUROMUSCULAR
EVITAR EL BALANCE NEGATIVO DE NITROGENO
TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS
TECNICAS DE AHORRO DE ENERGIA
ESTIMULACION SENSORIAL
ESTIMULAR SEDNETE
REENTRENAR EN MARCHA ASISTIDA
HIGIENE RESPIRATORIA
PREVENIR ESTREÑIMIENTO
EDUCACION EN PREVENCION DE CAIDAS
EDUCACION EN PLAN CASERO A FAMILIARES

Ayudas diagnó. ult. 24 horas:	Sin estudios pendientes:	X		
Responsable:	CATACOLI SAMAYOA, JOSE GERMAN	FISIATRIA	N. Identificación:	0016758733
RM:	18281498	Válido como firma electrónica		

Evoluciones Médicas

Fecha: 05-feb-25	Hora: 20:05:07	Tipo de Evolución:Evolución

NOTA OPERATORIA NEUROCIRUGIA

Se realizó resección de recidiva de glioblastoma multiforme talámico izquierdo a través del mismo abordaje. Se guió la resección con neuronavegación y ecografía intraoperatoría con transductor lineal de 7Hz.
Se dejó con ventriculostomía externa cerrada por seguridad.

Plan de Manejo
1) Observación en Cuidado intensivo
2) Resonancia magnética mañana 6am
3) Dexametasona 8mg cada 8 horas por 2 dias y disminuir a 4mg cada 8/h

J Lobato

Ayudas diagnó. ult. 24 horas:	Sin estudios pendientes:	X		
Responsable:	LOBATO POLO, JAVIER MAURICIO	NEUROCIRUGIA	N. Identificación:	0091481284
RM:	59500	Válido como firma electrónica		

Evoluciones Médicas

Fecha: 06-feb-25	Hora: 07:45:15	Tipo de Evolución:Evolución

NEUROCIRUGÍA

DIAGNÓSTICOS:
- RESECCIÓN LESIÓN TALÁMICA IZQUIERDA 12.05.2023
-- PATOLOGÍA: GLIOBLASTOMA IDH NATIVO KI 20-25%
- RECIDIVA TUMORAL TALÁMICA IZQUIERDA
-POSTQUIRURGICO DE RESECCION DE LESION TALAMICA IZQUIERDA POR CRANEOTOMIA VIA INTERFHEMISFERICA TRASNCALLOSA ANTERIOR 05.02.2025

SUBJETIVO: PASA BIEN LA NOCHE, SIN FIEBRE, HA MEJORADO LA FUERZA

OBJETIVO
SIGNOS VITALES:
TEMPERATURA: 37.1º CENTÍGRADOS
FRECUENCIA CARDIACA: 67 LATIDOS POR MINUTO
FRECUENCIA RESPIRATORIA: 16 RESPIRACIONES POR MINUTO
TENSIÓN ARTERIAL: 124/64 MMHG
SATURACIÓN: 97%

ALERTA, ORIENTADA
LENGUAJE FLUIDO, COMPRENDE, NOMINA, REPITE
PUPILAS 3MM, REACTIVAS, MOVIMIENTOS EXTRAOCULARES CONSERVADOS
CAMPIMETRÍA POR CONFRONTACIÓN SIN ALTERACIONES
PARESIA FACIAL CENTRAL DERECHA
HEMIPARESIA DERECHA FUERZA MIEBRO SUPERIOR 3/5 Y MIEMBRO INFERIOR 4/5
FUERZA 5/5 EN HEMICUERO IZQUIERDO
REFLEJOS ++
SENSIBILIDAD SIN ALTERACIONES
BABINSKI DERECHO
HERIDA QUIRURGICA CUBEIRTA CON APOSITO ESTERIL, SECA
CATÉTER VENTRICULAR CERRADO

05.02.2025
HEMOGLOBINA 13.5 LEUCOS 18320 PLAQUETAS 255.000 SODIO 139 CLORO 104 POTASIO 3.6

RESONANCIA CEREBRAL CONTRASTADA 06.02.2025
SE EVIDENCIAN CMABIOS POSTQUIRURGICOS POR CRANEOTOMIA FRONTAL DERECHA, ADECUADA RESECCION DE LESION TALAMICA IZQUIERDA ESCASO REALCE AL MEDIO DE CONTRASTE PERIFERICO, NO HAY SANGRADO DEL LECHO, CATETER VENTRICULAR BIEN POSICIONADO, NO HAY AREAS DE RESITRCCION EN LA DIFUSION

ANÁLISIS Y PLAN: PACIENTE EN POSTQUIRURGICO DE RESECCION DE LESION TALAMICA IZQUIERDA POR CRANEOTOMIA VIA INTERFHEMISFERICA TRASNCALLOSA ANTERIOR, PROCEDIMIENTO REALIZADO SIN COMPLICACIONES. EN EL MOMENTO ESTABLE, DEFICIT MOTOR ESTABLE. EN LA RESONANCIA CEREBRAL CONTROL SE EVIDENCIA ADECUADA RESECCION DE LESION, SIN COMPLICACIONES. POR NEUROCIRUGÍA PUEDE TRASLADARSE A PISO UNA VEZ CUMPLA VIGILANCIA 24 HORAS EN UCI. SE EXPLICA

JUAN CAMILO ARIAS
RESIDENTE NEUROCIRUGÍA

Ayudas diagnó. ult. 24 horas:	Anormal:	X	
Descripción de la anormalidad: CAMBIOS POSTQUIRURGICOS			
Responsable:	BELTRAN OSORIO, LUIS DAVID	NEUROCIRUGIA	N. Identificación: 1123631240
RM:	1123631240	Válido como firma electrónica	

Evoluciones Médicas

Fecha:	06-feb-25	Hora:	08:50:29	Tipo de Evolución:	Interconsulta Sicología

INTERCONSULTA PSICOLOGIA

SE RESPONDE A INTERCONSULTA SOLICITADA POR EQUIPO MÉDICO TRATANTE SEGUN LA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES EN RONDA DE CUIDADO INTERDISCIPLINAR

MOTIVO DE CONSULTA: ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL AL PACIENTE CON DIAGNOSTICO ONCOLOGICO.

KAROL GABRIELA VELEZ ROSERO
23 AÑOS
VIVE EN PUTUMAYO CON SUS PADRES Y HERMANOS
ES ESTUDIANTE DE PSICOLOGIA
CREEN EN DIOS

DIAGNÓSTICOS:
- RESECCIÓN LESIÓN TALÁMICA IZQUIERDA 12.05.2023
-- PATOLOGÍA: GLIOBLASTOMA IDH NATIVO KI 20-25%
- RECIDIVA TUMORAL TALÁMICA IZQUIERDA
-POSTQUIRURGICO DE RESECCION DE LESION TALAMICA IZQUIERDA POR CRANEOTOMIA VIA INTERFHEMISFERICA TRASNCALLOSA ANTERIOR 05.02.2025

ANTECEDENTES:
*PATOLOGÍA:
Células tumorales positivas para GFAP, Olig2 y S100. P53 no sobre-expresado. Índice de proliferación medido
mediante KI67 es del 20-25%.
IDH: Células tumorales negativas para IDH (R132H).
TUMOR TALAMICO IZQUIERDO - RESECCIÓN.
- GLIOBLASTOMA DE TIPO IDH NATIVO (GRADO 4 DE LA OMS) P53 NO SOBRE EXPRESADO
NIEGA ANTECEDENTES EN SALUD MENTAL.

SUBJETIVO:

En unidad de cuidados intensivos en compañía de su madre Ruby. La paciente refiere se siente tranquila, somnolienta. Su madre habla del proceso oncológico, cirugía inicial y tratamientos. Confían en Dios, se sienten felices por los resultados del procedimiento quirúrgico, esperanzados en su proceso de rehabilitación.

OBJETIVO:
Paciente acostada en camilla con vestuario e higiene acorde a la estancia hospitalaria. Tendencia a la somnolencia, actitud colaboradora. Establece contacto visual. Afecto modulado. Aparenta orientada. Tendencia a la hipoprosexia, cierra los ojos durante la entrevista y se queda dormida. Leve disartria. En el momento no es posible evaluar a profundidad el contenido del pensamiento.

ANALISIS:
Paciente de 23 años conocedora de condición clínica y planes de tratamiento y rehabilitación. Red de apoyo presente y movilizada pese a domicilio lejano. En el momento somnolienta, lo que limita la intervención individual. Recursos como unión familiar, creencias espirituales que facilitan la resignificación de la aparición de la enfermedad.

Con el fin de seguir aportando a su estabilidad, se realiza intervención de apoyo y soporte; favoreciendo la expresión emocional. Se resaltan y refuerzan recursos internos y redes de apoyo. Valido y brindo psicoeducación sobre posibles cambios afectivos durante el proceso de salud, así como estrategias de gestión y regulación emocional; buscando el continuo desarrollo y fortalecimiento estrategias de afrontamiento adaptativas. Se orienta sobre la posibilidad de solicitar el acompañamiento durante la estancia.

PLAN:
Se realizará seguimiento según cambios afectivos, en condición clínica y/o necesidades emergentes identificadas por el servicio a lo largo de la estancia hospitalaria con base a los siguientes objetivos:
-Favorecer la elaboración del duelo oncológico, así como la adaptación y adherencia a los tratamientos.
-Brindar soporte y psicoeducación en emociones.

NOTA: La valoración se realizó según el protocolo de bioseguridad y lavado de manos de la institución. No se incluyó datos de peso y talla en la historia clínica ya que no son competencia de esta disciplina.

Ayudas diagnó. ult. 24 horas:	Sin estudios pendientes:	X	
Responsable: CORZO MARTINEZ, VALENTINA MARIA	PSICOLOGIA	N. Identificación:	1143879610
RM: 271798	Válido como firma electrónica		

Evoluciones Médicas

Fecha:	06-feb-25	Hora:	11:46:20	Tipo de Evolución:	Evolución

S: Remitida por Neurocirugía para valoración prequirúrgica.

DIAGNÓSTICOS:
- RESECCIÓN LESIÓN TALÁMICA IZQUIERDA 12.05.2023
-- PATOLOGÍA: GLIOBLASTOMA IDH NATIVO KI 20-25%
- RECIDIVA TUMORAL TALÁMICA IZQUIERDA
-POSTQUIRURGICO DE RESECCION DE LESION TALAMICA IZQUIERDA POR CRANEOTOMIA VIA INTERFHEMISFERICA TRASNCALLOSA ANTERIOR 05.02.2025

Alerta, orientada en persona, espacio y tiempo. Procedente de Popayán, pero originaria de Putumayo. Estaba estudiando Psicología en la Fundación Universitaria. Refiere que todo inició hace 2 años cuando tuvo problemas para hablar, dolor de cabeza, vómito y dificultad visual que consultó a Urgencias donde tomaron un TAC y fue remitida a FVL por hallazgo de lesión cerebral. Fue operada para resección de lesión con manejo posterior de quimioterapia y radioterapia 30 sesiones. Agrega que tras esta intervención notó que la memoria no funcionaba bien y le costaba encontrar las palabras, pero nada de esto le afectó significativamente. Ahora anota que estuvo en el control por Neurocirugía y tras los resultados de la resonancia notaron que había recidiva de la lesión y por tal razón está a la espera de una segunda intervención. El síntoma predominante es la dificultad para la movilidad y fuerza de la pierna y luego el brazo, esta siente como que la mano no le obedece en algunas ocasiones. Maneja su dinero y hace sus pagos sin problema. Duerme y come bien. Esfínteres controlados. Se queja de estreñimiento. Niega caídas o TCE recientes. Escolaridad: 9° semestre de Psicología. Lateralidad: diestra.

Atención
TMT A: 24/24 secuencias correctas en 47 sgs [percentil 80]
Memoria
HVLT-R
I: 4
II: 5
III: 6
TOTAL: 15 [percentil 10]
EVOCACIÓN DIFERIDA: 4 [percentil 15]
RECONOCIMIENTO: 10/12 (3 errores con asociación semántica)

Lenguaje
Fluidez verbal semántica (flores): 4 [percentil <5]

Función ejecutiva
Fluidez verbal fonológica (letra P): 10 [percentil 40]
TMT B: 14/14 secuencias correctas en 108 sgs [percentil 70]
Retención de dígitos WAIS-IV: 15 [P. Escalar 5]
Aritmética WAIS-IV: 4 [P. Escalar 3]

A: Se hace entrevista inicial con la paciente y la madre para establecer el tipo de dificultades en la esfera cognitiva/comportamental. No se evidencia riesgo de suicidio, establece contacto visual. Según lo referido en la entrevista se sugiere que el tipo de compromiso de la paciente es compatible con un trastorno cognitivo (secundario a antecedente médico-quirúrgico).

P: Se hace protocolo de evaluación prequirúrgica. Pendiente realizar evaluación antes del egreso.

Ayudas diagnó. ult. 24 horas:	Sin estudios pendientes:	X

Responsable:	MUÑOZ OSPINA, BEATRIZ ELENA	NEUROPSICOLOGIA	N. Identificación:	0066786148
RM:	76089007	Válido como firma electrónica		

Evolución UCI

Fecha:	06-feb-25	Hora:	09:02:00

EVOLUCION UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DIA – 06.02.2025
KAROL GABRIELA VELEZ ROSERO, EDAD: 23 AÑOS, C.C: 1193103725

DIAGNÓSTICOS:
1.Postoperatorio resección tumoral talámica - 05.02.2025
1.1 Recidiva tumoral talámica izquierda
2. Antecedente de resección talámica izquierda - 12.05.2023
2.1 Patología: glioblastoma IDH nativo KI 20-25%

ANTECEDENTES:
-Patológicos: glioblastoma multiforme talámico izquierdo, pop resección 12 de mayo de 2023, culminó radioterapia en concomitancia con temozoladmida el 3/8/2023. Temozolamida por 6 meses más terminó en novimebre 2024
-Patología: células tumorales positivas para gfap, olig2 y s100. P53 no sobre-expresado. Índice de proliferación medido mediante ki67 es del 20-25%.
dh: células tumorales negativas para idh (r132h).
- glioblastoma de tipo idh nativo (grado 4 de la oms) p53 no sobre expresado.
Miomatosis uterina, ovarios poliquísticos.
-Alergias: niega
-Farmacológicos: Niega
-Quirúrgicos: biopsia estereotáxica el 20.04.2023
-Tóxicos: niega
-Familiares: niega
-Inmunológicos: 1 dosis para sars-cov 2

PROBLEMAS:
-postoperatorio de neurocirugía, riesgo de deterioro neurológico.

SUBJETIVO: Paciente refiere haber pasado buena noche, niega dolor.

EXAMEN FÍSICO: Paciente en cama, sin fiebre, tranquila.

CARDIOVASCULAR: Frecuencia cardiaca: 67 /latidos por minuto Tensión arterial: 124/64 mmHg Tensión arterial media: 84 mmHg
Ruidos cardiacos rítmicos no ausculto soplos.

RESPIRATORIO: Frecuencia respiratoria: 14 /respiraciones por minuto Saturación de O2: 95% Fracción Inspirada de O2: 0.21
Campos pulmonares ventilados, sin ruidos sobreagregados, murmullo vesicular presente. Traqueostomia percutánea.
-Gases arteriales pH: pCO2: pO2: HCO3: SatO2: % BE:

GASTROINTESTINAL: Abdomen blando depresible no doloroso a la palpación no signos de irritación peritoneal, peristaltismo presente

HEMATOLÓGICO: Sin signos de sangrado activo.
- Hemoglobina: 13.4 Hematocrito: 38% Plaquetas: 248.000

INFECCIOSO:

Responsable:	MEDINA, CAMILO ANDRES	N. Identificación:	6550699
RM:	7621842013	Válido como firma electrónica	

FUNDACIÓN VALLE DEL LILI
Excelencia en Salud al servicio de la comunidad

PACIENTE:	**KAROL GABRIELA VELEZ ROSERO**	**FECHA:**	25-01-2025 08:26 a. m.
Nº ID:	1193103725	**EDAD::**	23
TIPO	Ambulatorio	**SEXO:**	Mujer

Estudio

RESONANCIA MAGNÉTICA DE CEREBRO CON CONTRASTE

INDICACIÓN CLÍNICA: GLIOBLASTOMA TALÁMICO IZQUIERDO, EN SEGUIMIENTO.

ESTUDIOS COMPARADOS: RESONANCIA MAGNÉTICA DEL 22 DE ABRIL DE 2024.

Técnica

Con equipo superconductor 1.5 T se realizan adquicisiones volumétricas potenciadas en T1 y atenuación de líquido en T2 de derecha a izquierda sagital. Axiales en T2, gradiente de eco, difusión, coeficiente de difusión. Coronales en T2. Posterior al contraste (ácido Gadotérico: 15 ml) se obtienen mapas de perfusión y cortes axiales en T1 turbo spin eco y volumétricas en gradiente eco potenciadas en T1.

Hallazgos

Cambios post quirúrgicos de craneotomía frontoparietal izquierda, en el lecho quirúrgico se visualiza actualmente una masa centrada en el tálamo izquierdo, hiperintensa secuencias potenciadas en T2, isointensa en secuencias potenciadas en T1 y con realce grueso, irregular en su periferia. Dicha masa mide 3,5 x 2,6 x 2,8 cm (longitudinal x anteroposterior x transverso). Presenta algunas áreas de restricción a la difusión especialmente en su aspecto superior. Se asocia también a aumento del volumen cerebral.

En su periferia se observan áreas de hiperintensidad en secuencias potenciadas en T2, que la aumentado significativamente respecto a estudio previo y que ahora se comprometen especialmente la sustancia blanca de los giros precentral y poscentral izquierdos, de los giros frontal superior, medio e inferior y el giro parietal superior y el polo temporal ipsilaterales. Además la ínsula, cápsula interna y el pedúnculo cerebral izquierdos. Esto en relación con edema o enfermedad no medible. Dichas áreas ejercen efecto de masa que condiciona disminución de la amplitud de los surcos del espacio subaracnoideo adyacente. También disminución de la amplitud del ventrículo lateral izquierdo y del tercer ventrículo.

Se observa orificio de trépano frontal derecho, con área encefalomalacia en el giro frontal superior, el giro del cíngulo ipsilaterales y en el cuerpo del cuerpo calloso.

La intensidad de señal del resto del parénquima cerebral es normal.

No hay lesiones selares ni para selares.

IV ventrículo central, sin aparentes lesiones en fosa posterior.

Cisternas de la base libres. La unión craneocervical es normal.

No colecciones epi o subdurales o signos de hemorragia subaracnoidea.

Adecuada permeabiliad de los vasos del polígono de Willis y de los senos venosos.

Órbitas y senos paranasales de aspecto normal.

Escasa efusión mastoidea bilateral.

Avenida Simón Bolivar Cra. 98 No. 18-49
Conmutador: 331 90 90
Fax: 331 67 28
Nit. 890.324.177-5
Cali - Colombia
www.valledellili.org..

Fecha Aprobacion:05-02-2025 03:36 p. m.

Opinión

CAMBIOS POST QUIRÚRGICOS DE CRANEOTOMÍA PARA RESECCIÓN DE GLIOMA TALÁMICO IZQUIERDO, AHORA CON UNA MASA TALÁMICA IZQUIERDA COMPATIBLE CON RECIDIVA TUMORAL.

SE OBSERVA TAMBIÉN AUMENTO MARCADO DE LAS ÁREAS DE HIPERINTENSIDAD EN SECUENCIAS POTENCIADAS EN T2, ASOCIADAS A EDEMA O ENFERMEDAD NO MEDIBLE.

Dr Dario Alfredo Lasso Ramirez
Médico Residente
RM 1085935810

Dra Ana Maria Granados Sánchez
Médico Radiólogo
RM 584393

Avenida Simón Bolivar Cra. 98 No. 18-49
Conmutador: 331 90 90
Fax: 331 67 28
Nit. 890.324.177-5
Cali - Colombia
www.valledellili.org..

Fecha Aprobacion:05-02-2025 03:36 p. m.